

Epizody *mieszane*

Manii i depresja jednocześnie: energia hipomanii + ciężka beznadziejność. Najwyższe ryzyko samobójcze ze wszystkich faz BD. Specyfika, sygnały, działanie.

CZAS: 15 min — psychoedukacja **CHARAKTER:** rozpoznanie, profilaktyka SI

ŹRÓDŁO: Akiskal (2008); APA DSM-5 (2013)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się rozpoznawać **cechy mieszane** (DSM-5: ≥ 3 objawy biegunu przeciwnego podczas epizodu). Jeśli zauważasz u siebie depresję z drażliwością/pobudzeniem/zalewem myśli — to *nie* klasyczna depresja. Wymaga innego leczenia (antydepresant *może pogorszyć*). Skontaktuj się z psychiatrą **w ciągu tygodnia**. Plan kryzysowy bardziej zdecydowany niż w „zwykłych” epizodach.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Akiskal (2008): „*epizody mieszane są najbardziej ryzykowną postacią BD — energia biegunu manii + cierpienie biegunu depresji = zdolność wykonania planów samobójczych*”. Pacjenci w depresji „pełnej” są często za wyczerpani na działanie. W mieszanym — energia jest. Goldberg (2009): **40%** prób samobójczych w BD następuje w fazie mieszanej.

01 ? Cechy mieszane — DSM-5

Depresja z ≥ 3 objawami manii LUB mania z ≥ 3 objawami depresji.

DEPRESJA Z CECHAMI MIESZANYMI

Niski nastrój + drażliwość/rozkojarzenie + pobudzenie psychoruchowe + gonitwa myśli + zalewające myśli + bezsensowność (mimo wyczerpania) + zwiększona energia w gniew/agresję.

MANIA Z CECHAMI MIESZANYMI

Euforia/podwyższona energia + płaczliwość + poczucie winy + spowolnienie w pewnych chwilach + myśli samobójcze + utrata przyjemności (mimo aktywności).

02 ✕ Specyfika ryzyka samobójczego

Dlaczego epizody mieszane są najbardziej niebezpieczne:

- **Cierpienie** biegunu depresji + **energia/impulsywność** biegunu manii
- Drażliwość + pobudzenie obniżają tolerancję na ból
- Trudność z zasypianiem nasila wyczerpanie i myśli
- Gonitwa myśli + beznadziejność = trudność z planowaniem rozwiązań
- Antydepresanty mogą *nasilać* pobudzenie i ryzyko

Czerwone flagi — telefon do psychiatry w ciągu 24h: myśli samobójcze + energia/pobudzenie · planowanie konkretnych działań · bezsensowność > 3 dni · agresja wobec siebie/innych.

03 ✓ Plan działania w fazie mieszanej

Zdecydowany, krótkoterminowy plan na okres 1-2 tygodni.

1. Wizyta u psychiatry w *ciągu tygodnia*. Zgłoś specyfikę („depresja z pobudzeniem, niemożliwym snem”) — to *nie* klasyczna depresja.
2. Weryfikacja farmakoterapii. Często konieczna zmiana: stabilizator + neuroleptyk atypowy (kwetiapina, olanzapina, aripiprazol). Antydepresant może wymagać *odstawienia*.
3. Redukcja stymulacji. *Bez* mediów, mediów społecznościowych, alkoholu, kawy po południu, intensywnych spotkań.
4. Stała obecność *bliskiej osoby* w pobliżu. Wieczory i noce — nie sam/-a.
5. Bezpieczeństwo — schowaj lekarstwa, ostre przedmioty u zaufanej osoby. Plan na noc (telefon, kontakt).
6. Telefon zaufania pod ręką: **116 123** (Polskie Towarzystwo Suicydologiczne), **800 70 2222** (Centrum Wsparcia).

04 ✎ Mój plan

SYGNAŁY, ŻE TO FAZA MIESZANA (U MNIE)

PSYCHIATRA — TELEFON, E-MAIL

do kontaktu w 24h

BLISKA OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ WIECZORAMI

CO USUWAM Z DOMU (LEKARSTWA, OSTRE PRZEDMIOTY)

TELEFONY ZAUFANIA

05 📅 Dziennik bieżący

DZIEŃ	SEN (H)	NASTRÓJ 0–10	POBUDZENIE 0–10	MYŚLI SI tak/nie	KONTAKT Z BLISKIM kto	DZIAŁANIE

Klucz: Akiskal (2008): „epizody mieszane wymagają **natychmiastowej** reakcji medycznej i społecznej — pacjent ma narzędzia (energię, plan) do działania, ale w sposób autodestrukcyjny”. Nie zostawaj sam/-a w tej fazie.